

Сценарій № 3

Ви лікар приймального відділення дитячої клінічної лікарні.

До Вас звернулася мати дитини 5-ти років зі скаргами на зниження апетиту, жовтяницю шкіри та склер.

Із анамнеза відомо, що дитина захворіла п'ять діб тому, коли з'явилися млявість, швидка втома, поганий апетит, періодична нудота. За медичною допомогою не зверталися. На шосту добу мати помітила темний колір сечі та жовті склери.

Анамнез життя: Ріс та розвивався відповідно до віку.

Епідеміологічний анамнез: дитина вживає некіп'ячену воду з крану.

Об'єктивно: стан дитини середньо тяжкий, що обумовлено ознаками інтоксикації. Шкіра жовтого кольору, склери іктеричні. При аускультатії органів дихання – без особливостей. ЧД 22/хв. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця ясні, ритмічні, ЧСС 100 уд/хв. При пальпації живота печінка виступає на 4,0 см з-під краю реберної дуги, край гострий, болісний. Селезінка – не пальпується. Сеча темного кольору. Стул ахолічний.

Біохімічний аналіз крові:

Загальний білок, г/л 68,0

(66-83)

АлАТ, од/л – 460 (до 36)

АсАТ, од/л – 312 (до 41)

Білірубін загальний, мкмоль/л - 68,7 (3-21)

Білірубін прямий, мкмоль/л - 53,5 (до 5)

Білірубін непрямий, мкмоль/л 1- 5,2 (до 15)

Маркери гепатитів:

Anti-HAVIgM 2,34 Од\л

HBs Ag 0,45 Од\л

Anti-HCV total 0,28 Од\л

Референтні значення для кожного показника :

Індекс < 0,90 - негативно

Індекс = 0,90- < 1,00 – сумнівно

індекс $\geq 1,00$ - позитивно

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановити контакт з пацієнтом та батьками/опікунами (привітатись, представитися, позначити свою роль). Коректне розташування лікар-пацієнт	Сказати Доброго дня. Я лікар педіатр.
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного обстеження дитини	Сказати Чи даєте Ви свою згоду на проведення клінічного обстеження Вашої дитини (Будемо вважати що згода отримана)
2.Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнта (зі слів батьків/опікунів)	Сказати: Скільки років дитині? Очікувана відповідь: 5 років Сказати: Які скарги у дитини?

		Очікувана відповідь: скарги на зниження апетиту у дитини, жовтушність шкіри та склер
2.2	Анамнез захворювання	Сказати: «Коли захворіла та які особливості захворювання мала дитина?» Очікувана відповідь: хворіє 5 діб, на 6-й день хвороби змінився колір сечі. Вживала некип'ячену воду з крану».
2.3	Анамнез життя	Як дитина розвивалась? Чим хворіла? Щеплення? Алергія? Травми, операції? Спадковість?
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавички та оцінити загальний стан дитини	Виконати/сказати Будемо вважати, що руки оброблені Сказати:стан дитини середньо тяжкий, що обумовлено інтоксикацією та наявністю жовтяниці.
3.2	Обстеження шлунково-кишкового тракту.	Сказати:при пальпації печінка виступає на 4,0 см з під краю реберної дуги, край гострий, болісний. Селезінка – не пальпується. Сеча темного кольору. Стула холічний. Серце і легені – без особливостей.
4.Діагностика		
4.1	Визначити результат біохімічного аналізу крові	АЛТ АСТ ++ - наявність цитолізу, гіпербілірубінемія за рахунок прямої фракції білірубіна.
4.2	Визначити результат маркерів гепатитів	маркери гепатитів свідчать про наявність гепатиту А
4.3	Визначити провідний синдром	інтоксикаційний та жовтяниця
4.4	Встановити клінічний діагноз	Гепатит А, гострий, типовий перебіг, неускладнений.
5.Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення пацієнта	Госпіталізація в інфекційний стаціонар. Дієта н5, дробне харчування, сорбенти.
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	раціональне харчування, підтримання правил особистої гігієни
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнта/батьків/опекунів про можливі ризики та етичні аспекти	Ви повинні знати про можливі ускладнення гепатиту А – печінкова енцефалопатія.

